Клинические рекомендации

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K21** — Гастроэзофагеальный рефлюкс **K21.0** — Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом **K21.9** — Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 30.09.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Союз педиатров России; Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"; Национальная ассоциация детских реабилитологов; Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/402_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 6

3.3 Визуальный осмотр, пальпация, аускультация 6

3.4 Общий (клинический) анализ крови 6

3.5 Кислотно-основное состояние и электролиты крови 7

3.6 Исследование кала на скрытую кровь 7

3.7 Ультразвуковое исследование пищевода с водно-сифонной пробой 7

3.8 Эзофагогастродуоденоскопия 7

3.9 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием 8

3.10 Внутрипищеводная pH-метрия 8

3.11 Суточная pH-импедансометрия 9

3.12 Пищеводная манометрия 9

3.13 Дифференциальная диагностика 9

4. Лечение 10
4.1 Лечение детей первого года жизни и раннего возраста 10
4.2 Немедикаментозное лечение детей старшего возраста 11
4.3 Медикаментозное лечение детей старшего возраста 11
4.4 Противорецидивное лечение 12
4.5 Хирургическое лечение 13
4.6 Иное лечение 13
4.7 Медицинская реабилитация 13
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 14
5.1 Показания к госпитализации 14
5.2 Диспансерное наблюдение 14
5.3 Профилактика 14
5.4 Осложнения и прогноз 15
6. Источник и актуальность 15
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 15

1. Основные положения

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — состояние, при котором заброс содержимого желудка в пищевод вызывает беспокоящие симптомы и (или) осложнения.
- Оториноларингологические проявления ГЭРБ: першение и охриплость голоса, гипертрофия аденоидов (после исключения персистирующих вирусных инфекций и аллергического ринита), рецидивирующие отиты; у детей старшего возраста также ночной храп и утренний кашель.
- Диагноз устанавливается только при стойкой «пищеводной» симптоматике или чёткой связи симптомов с эпизодами рефлюкса после исключения альтернативных диагнозов.
- Грудным детям с неосложнённым рефлюксом лекарства рутинно не назначаются: симптомы, как правило, исчезают самостоятельно **после 6 месяцев**. Сначала применяют терапию положением, затем антирефлюксные смеси.
- Детям **старше 1 года** с пищеводными проявлениями препаратами выбора являются ингибиторы протонного насоса курсом **4–8 недель**.
- Фундопликация по Ниссену рассматривается при рефрактерном течении (нет ремиссии за **4–8 недель** приёма ингибиторов протонного насоса) и жизнеугрожающих осложнениях, только при чётко доказанной ГЭРБ и после исключения других причин симптомов.
- Неотложная госпитализация показана при повторяющихся эпизодах апноэ и обильном кровотечении из эрозий или язв пищевода.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) — непроизвольный ретроградный заброс желудочного либо желудочно-кишечного содержимого в пищевод.

У детей старшего возраста ГЭРБ понимается шире: хроническое рецидивирующее заболевание с нарушением моторно-эвакуаторной функции верхних отделов ЖКТ, регулярным забросом содержимого в пищевод, пищеводными и внепищеводными симптомами, повреждением слизистой оболочки дистального отдела пищевода вплоть до эрозивно-язвенного эзофагита и цилиндроклеточной метаплазии. У детей раннего возраста ведущее значение имеет морфофункциональная незрелость.

2.2 Этиология и патогенез

Непосредственной причиной ГЭРБ является гастроэзофагеальный рефлюкс. Заболевание развивается при нарушении равновесия между факторами агрессии (гиперсекреция соляной кислоты, лизолецитин, желчные кислоты, панкреатический сок при дуоденогастральном рефлюксе, некоторые лекарства и продукты) и факторами защиты (антирефлюксная функция кардии, резистентность слизистой оболочки, клиренс пищевода, своевременная эвакуация из желудка).

У подростков распространённость ГЭРБ составляет 12,4–18,8%. У детей с неврологическими нарушениями, хроническими заболеваниями лёгких (в том числе муковисцидозом), ожирением и после операций по поводу пороков развития пищевода ГЭРБ выявляется более чем в 70% случаев.

2.3 Классификация

1. **неэрозивная (НЭРБ)**: протекает без видимых эрозий слизистой оболочки пищевода, включая эндоскопически негативную форму; составляет около 60% случаев;
2. **эрозивная (эрозивный эзофагит)**: протекает с эрозиями слизистой оболочки пищевода; составляет около 35% случаев; указывают стадию A–D по Лос-Анджелесской классификации.

Внепищеводные проявления

1. бронхолёгочные;
2. оториноларингологические;
3. кардиологические;
4. стоматологические.

Осложнения

1. язва пищевода, кровотечение, перфорация;
2. стриктура или стеноз пищевода;
3. постгеморрагическая анемия;
4. пищевод Барретта.

Лос-Анджелесская классификация эрозивного рефлюкс-эзофагита (1994)

Стадия	Эндоскопические критерии
A	одно или более повреждений слизистой оболочки, каждое не более 5 мм в длину
B	хотя бы один дефект более 5 мм в длину, не распространяющийся между вершинами соседних складок
C	хотя бы один дефект, распространяющийся между вершинами соседних складок, но не циркулярный (менее 75% окружности пищевода)
D	дефект, занимающий не менее 75% окружности пищевода

Лос-Анджелесская классификация не содержит критериев неэрозивных изменений слизистой оболочки, поэтому врач-эндоскопист описывает признаки минимально выраженного или неэрозивного рефлюкс-эзофагита в протоколе отдельно.

2.4 Клиническая картина

Пищеводные симптомы

1. **изжога** — ключевая жалоба подростков, у детей дошкольного и младшего школьного возраста может отсутствовать;
2. **регургитация** — пассивное продвижение желудочного содержимого в нижнюю часть глотки, полость рта и за её пределы; усиливается лёжа и при наклоне туловища;
3. **отрыжка** воздухом, кислым, горьким; отрыжку кислым пациенты нередко принимают за изжогу.

Боль и нарушение глотания

1. **боль за грудиной, одинофагия** — у детей встречается относительно редко;
2. **дисфагия** — ощущение препятствия прохождению пищи; после любой пищи более характерна для эзофагита, после жидкой — для функциональных нарушений, после твёрдой нередко указывает на органическую патологию (опухоль, стриктура, стеноз);
3. **парадоксальная дисфагия** (симптом Лихтенштерна) — твёрдая пища проходит лучше жидкой.

Ком в горле (globus pharyngeus) — ощущение кома в горле, не связанное с глотанием. Возникает из-за отражённых болей при эзофагите, дискоординации мышц пищевода, крикофарингеальной гипертензии или прямого раздражения рефлюксатом слизистой оболочки гортани.

Внепищеводные симптомы

1. длительный хронический кашель, ночные приступы кашля и (или) удушья после обильной еды;
2. рецидивирующий бронхит, пневмония;
3. апноэ у детей раннего возраста;
4. периодическое першение и охриплость голоса;
5. гипертрофия аденоидов — при исключении хронических персистирующих вирусных инфекций и аллергического ринита;
6. рецидивирующие отиты;
7. нарушения ритма и проводимости сердца;
8. эрозии эмали зубов.

Изолированно, без основных жалоб, внепищеводные проявления встречаются редко. Иногда ГЭРБ выявляется только при эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), выполненной по поводу патологии желудка и двенадцатиперстной кишки.

Дети раннего возраста

1. рецидивирующие рвоты, срыгивания;
2. снижение массы тела;
3. рвота фонтаном, рвота с примесью крови или желчи;
4. респираторные нарушения вплоть до апноэ и синдрома внезапной смерти.

Частота срыгиваний снижается с 50–66% в первом полугодии до 5–10% к концу первого года жизни.

Степень тяжести срыгиваний у детей первого года жизни

Степень тяжести	Срыгивания
лёгкое течение	до 3–5 срыгиваний в день, объёмом 2,5–5,0 (единица измерения в КР не указана)
среднетяжёлое течение	в половине кормлений или чаще, до 1/2 объёма съеденной пищи
тяжёлое течение	более чем в половине кормлений, объём более 1/2 кормления и (или) отставание в физическом развитии

Патологический рефлюкс у детей первого года жизни встречается с частотой 8–11%. Среди причин выделяют натальную травму шейного отдела позвоночника, аллергию к белкам коровьего молока, лактазную недостаточность, скользящую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, нарушение вегетативной регуляции, недоношенность.

У детей первого года жизни и раннего возраста судить о наличии и выраженности эзофагита только по клиническим проявлениям невозможно.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. жалоб с учётом выраженности симптомов: у детей раннего возраста субъективные симптомы ненадёжны, большинство симптомов неспецифичны;
2. анамнеза: заболевания, при которых ГЭРБ встречается чаще, ранее установленный диагноз ГЭРБ;
3. инструментальных данных при необходимости: рентгеноскопия пищевода с контрастированием, ЭГДС, pH-метрия, pH-импедансометрия, манометрия.

Диагноз ГЭРБ устанавливается только при стойкой клинической («пищеводной») симптоматике или при чёткой связи симптомов с эпизодами рефлюкса и исключении альтернативных диагнозов.

ГЭРБ считается рефрактерной при отсутствии убедительной клинической и эндоскопической ремиссии в течение **4–8 недель** терапии стандартной дозой ингибиторов протонного насоса.

3.2 Жалобы и анамнез

Симптомы у детей первого года жизни и раннего возраста

1. персистирующие срыгивания, рвоты;
2. повышенное беспокойство, плач, усиливающиеся во время кормления;
3. снижение аппетита, отказ от еды, затруднения при глотании;
4. в тяжёлых случаях — плохие прибавки массы тела;
5. персистирующий кашель, стридор, в тяжёлых случаях — апноэ и аспирационная пневмония;
6. персистирующая икота.

Симптомы у детей старшего возраста

1. персистирующие рвоты;
2. изжога, дисфагия, отрыжка, боль за грудиной;
3. кислый, горький или другой неприятный привкус во рту;
4. ночной храп как проявление синдрома обструктивного апноэ сна;
5. утренний кашель, осиплость голоса;
6. поражение зубной эмали.

Специфических симптомов ГЭРБ нет, поэтому для дифференциальной диагностики оценивают симптомы тревоги.

Симптомы тревоги

1. рвота с примесью желчи, ночная или упорная рвота;
2. стойкая дисфагия;
3. увеличение живота в объёме;
4. гематемезис;
5. лихорадка;
6. патологические изменения при осмотре со стороны ЖКТ, дыхательной, сердечно-сосудистой или нервной системы;
7. потеря массы тела, отставание в физическом развитии;
8. нарушение психомоторного развития;
9. рецидивирующие бронхиты, пневмонии.

Если диагноз ГЭРБ не подтверждён, по алгоритму КР проводится диагностический поиск в рамках других заболеваний с консультациями оториноларинголога и пульмонолога; при осложнениях показана консультация детского хирурга.

3.3 Визуальный осмотр, пальпация, аускультация

Ребёнку с клиническими признаками ГЭРБ показан стандартный полный осмотр: визуальный осмотр, пальпация, аускультация. Патогномоничных для ГЭРБ физикальных симптомов нет.

3.4 Общий (клинический) анализ крови

При рвоте и плохой прибавке массы тела выполняется общий развёрнутый анализ крови для исключения инфекционной природы симптомов и сопутствующих состояний, таких как анемия.

Анемия носит железодефицитный характер: гипохромная, микро- или нормоцитарная, норморегенераторная; уровень железа и ферритина снижен, железосвязывающая способность сыворотки повышена.

3.5 Кислотно-основное состояние и электролиты крови

При рвоте и плохой прибавке массы тела определяют pH и буферные основания крови, натрий, калий и хлориды для контроля водно-электролитного состояния и исключения ацетонемического синдрома.

3.6 Исследование кала на скрытую кровь

Детям **до 1 года** с рвотой и плохой прибавкой массы тела показано исследование кала на скрытую кровь, желательно иммунохимическим методом: в этом возрасте подобные жалобы нередко обусловлены аллергией к белкам коровьего молока.

3.7 Ультразвуковое исследование пищевода с водно-сифонной пробой

Показание: подозрение на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы; после УЗИ выполняется рентгеноскопия желудка.

Нормальный диаметр пищевода у детей 7–10 мм. При диаметре **более 13 мм** (во время глотка **15 мм и более**) заключение о скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы становится практически достоверным.

Для диагностики самой ГЭРБ УЗИ Европейским обществом детских гастроэнтерологов не рекомендуется: чувствительность около 95%, специфичность 11%.

3.8 Эзофагогастродуоденоскопия

ЭГДС проводится детям с подозрением на ГЭРБ для диагностики и дифференциальной диагностики; обязательна при симптомах тревоги.

Исследование позволяет

1. выявить врождённые аномалии верхних отделов ЖКТ (атрезии, стенозы, «короткий пищевод»);
2. диагностировать эрозивный рефлюкс-эзофагит;
3. выявить осложнения: пептический стеноз, язвы пищевода, пищевод Барретта;
4. исключить эозинофильный и инфекционный эзофагит, воспалительные заболевания кишечника;
5. выявить грыжу пищеводного отверстия диафрагмы;
6. выявить опухоли и проконтролировать пищевод после операций.

Эрозивные дефекты слизистой оболочки (без уточнения размера) при наличии симптомов подтверждают диагноз; тяжесть оценивают по Лос-Анджелесской классификации.

Нормальная эндоскопическая картина ГЭРБ не исключает. Лечение ингибиторами протонного насоса до ЭГДС переводит эрозивную форму в неэрозивную и снижает чувствительность исследования.

Признаки минимально выраженного рефлюкс-эзофагита (фиксируются в протоколе)

1. спрямление, уплотнение, мелкие треугольные выпячивания и сегментарные подъёмы Z-линии менее 10 мм;
2. гиперемия и мельчайшие эрозии в зоне пищеводно-желудочного соединения;
3. реактивная гиперплазия кардиального эпителия с гиперпластическими полипами или без них;
4. линейное утолщение слизистой оболочки по верхушкам складок нижней трети пищевода (белесые полосы).

При технической возможности используют осмотр в узком спектре света.

Детям ЭГДС, по возможности, проводится под общей анестезией или глубокой седацией.

Биопсия пищевода с гистологическим исследованием проводится для дифференциальной диагностики (эозинофильный эзофагит, болезнь Крона, инфекционный эзофагит) и своевременного выявления пищевода Барретта.

Берут не менее двух биоптатов (лучше четыре) на **2 см и более выше Z-линии**. Микроскопические изменения ГЭРБ не подтверждают и не исключают, поэтому рутинная биопсия для диагностики ГЭРБ нецелесообразна.

Пищевод Барретта диагностируется по эндоскопическому и гистологическому критериям. Сегмент метаплазии описывают по Пражским критериям C&M; при подозрении используют формулировку «подозрение на цилиндроклеточную метаплазию пищевода» с указанием протяжённости и берут множественные биоптаты. Группа риска поздней диагностики — дети с тяжёлой патологией опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью (ДЦП).

Выполняется четырёхквадрантная биопсия через каждый 1 см циркулярного сегмента метаплазии, больше биоптатов — у проксимального края «языков пламени». При обнаружении цилиндрического эпителия устанавливается диагноз пищевода Барретта независимо от наличия кишечной метаплазии и длины сегмента.

3.9 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

Показания: рефрактерное течение (нет ремиссии за **4–8 недель** терапии) и подозрение на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы по данным ЭГДС; цель — дифференциальная диагностика и выявление анатомических аномалий.

У детей первого года жизни показанием является повторяющаяся рвота давностью **более 3 суток**, если нет симптомов, определённо указывающих на механическую или функциональную непроходимость.

Исследование выполняется натощак, перед очередным кормлением. Объём бария сульфата соответствует разовому кормлению: детям **до 3 месяцев** 40–80 мл, старше — 60–200 мл; более 200 мл давать нецелесообразно.

Водно-сифонная проба (питьё воды лёжа) положительна при забросе бария из желудка в пищевод. У младенцев проба с компрессией живота положительна при двух и более эпизодах заброса за 30 секунд. При отрицательном результате осматривают в положении Тренделенбурга; нагрузочная проба с густым барием оценивает моторику пищевода и работу сфинктеров.

3.10 Внутрипищеводная pH-метрия

Показания (при возможности): подозрение на неэрозивную или рефрактерную ГЭРБ, выраженные и (или) стойкие внепищеводные симптомы. Метод регистрирует только кислые рефлюксы.

Один из электродов устанавливают на 5 см выше кардии. Нормативы T. R. DeMeester применимы у детей **старше 12 лет**, а у детей до года используют нормативы J. Boix-Ochoa. При кислотном рефлюксе нормальный индекс рефлюкса (доля времени с pH < 4) составляет 4,45%.

Метод доступен не везде, поэтому ребёнка направляют в специализированный стационар или консультативный центр.

Нормальные показатели суточной pH-метрии по T. R. DeMeester

Показатель	Норма
время с pH < 4, общее	4,5%
время с pH < 4, стоя	8,4%
время с pH < 4, лёжа	3,5%
число эпизодов рефлюкса	46,9

Показатель	Норма
число эпизодов рефлюкса длительнее 5 минут	3,5
самый длинный эпизод с pH < 4	20 минут

Нормальные показатели суточной pH-метрии у детей до 1 года по J. Boix-Ochoa

Показатель	Среднее значение	Верхняя граница нормы
общее время с pH < 4	1,9 ± 1,6%	5,0%
число эпизодов рефлюкса	10,6 ± 8,8	27,0
число эпизодов длительнее 5 минут	1,7 ± 1,2	5,8
самый длинный эпизод, минуты	8,1 ± 7,2	22,5

3.11 Суточная pH-импедансометрия

Показания (при возможности)

1. рефрактерная ГЭРБ;
2. неэрозивная ГЭРБ;
3. выраженные внепищеводные симптомы.

Исследование позволяет

1. уточнить характер рефлюкса: кислотный, щелочной, смешанный;
2. связать симптомы (кашель, боль за грудиной) с эпизодами рефлюкса;
3. выявить детей со свистящим дыханием и другими респираторными симптомами, у которых рефлюкс является отягощающим фактором.

Метод выявляет и некислотный рефлюкс, определяет высоту заброса и риск аспирации. Щелочной и смешанный рефлюкс выявляются не менее чем у половины детей; норм для щелочного рефлюкса нет, сам факт заброса дуоденального содержимого в пищевод патологичен.

3.12 Пищеводная манометрия

Показания (селективно): отсутствие ремиссии за **4–8 недель** стандартной терапии, подозрение на нарушение моторики пищевода, предстоящая антирефлюксная операция.

Нижние границы нормы нижнего пищеводного сфинктера: давление 6 мм рт. ст., длина 2 см, внутрибрюшной сегмент 1 см. Исследование сложно провести у детей младше 15 лет.

3.13 Дифференциальная диагностика

1. **заболевания пищевода**: острый и хронический эзофагит, язва, стеноз, дивертикулы, опухоли пищевода, склеродермия, сидеропения;
2. **заболевания нервной и мышечной систем**: эзофагоспазм, атония пищевода, ахалазия кардии;
3. **сдавление пищевода соседними органами**: опухоли и кисты средостения, инородные тела, задний медиастинит, плевропульмональный фиброз, митральный порок, аневризма и праволежащая аорта, аномалии сосудов, увеличение щитовидной железы;
4. **другие причины**: лекарственное воздействие, психические заболевания.

4. Лечение

Тактика у детей с ГЭРБ

1. стартовое лечение ингибиторами протонного насоса около **8 недель**;
2. наблюдение после отмены препарата;
3. при возвращении симптомов — рентгеноконтрастное и при необходимости другие инструментальные исследования;
4. при отсутствии эффекта — рассмотреть хирургическое лечение (лечение, наблюдение и оценка результатов занимают в среднем около **1 года**).

Терапия комплексная, ступенчатая: нормализация образа жизни, режима дня и питания; медикаментозная терапия (моторика пищевода и желудка, кислотообразование, восстановление слизистой оболочки); хирургическое лечение.

4.1 Лечение детей первого года жизни и раннего возраста

Первый шаг — терапия положением: при кормлении ребёнка держат под углом **45–60°**, ночью головной конец кроватки приподнимают на **10–15 см**. Перекармливание недопустимо.

При неэффективности терапии положением назначают антирефлюксные молочные смеси с загустителями: они уменьшают частоту рефлюкса.

Варианты назначения антирефлюксной смеси

1. в начале каждого кормления адаптированной смесью — 1/2–1/4 объёма кормления;
2. 1–3 раза в день в объёме кормления, в остальные кормления — адаптированная смесь;
3. в полном суточном объёме, длительность индивидуально.

При отсутствии эффекта и плохих прибавках массы тела применяют смесь на основе глубокого гидролиза белка или аминокислотную. Отсутствие улучшения за **2 недели** свидетельствует о неэффективности, и ребёнка возвращают на прежнюю смесь. При положительном эффекте смесь продолжают **до 12 месяцев, но не менее 6 месяцев**.

Смеси с неперевариваемыми полисахаридами (камедь рожкового дерева) лечебные и назначаются врачом: объём подбирают (1/2, 1/3 или 1/4 суточного рациона), длительность — по клинике, до 2–3 месяцев; здоровым детям без срыгиваний не рекомендуются. Вместе с терапией положением эффективны в 90–95% случаев.

Грудным детям с неосложнённым рефлюксом медикаментозная терапия рутинно не рекомендуется: в большинстве случаев симптомы исчезают самостоятельно **после 6 месяцев**.

Вопрос о медикаментозном лечении грудных детей с синдромом срыгивания решается строго индивидуально и схематизации не подлежит.

Ингибиторы протонного насоса показаны детям **старше 1 года** с выраженными симптомами (беспокойство, отказ от кормления, плохая прибавка массы тела) и эзофагитом средней и тяжёлой степени при неэффективности немедикаментозного лечения. Дозы назначают согласно инструкции.

4.2 Немедикаментозное лечение детей старшего возраста

Всем детям и подросткам с ГЭРБ рекомендуется изменение образа жизни.

Рекомендации по изменению образа жизни

1. спать с головным концом кровати, приподнятым не менее чем на 15 см;
2. снизить содержание жира и объём пищи, повысить содержание белка, избегать раздражающих продуктов (цитрусовые соки, томаты, кофе, чай, шоколад, мята, лук, чеснок);
3. снизить массу тела при ожирении;
4. не есть перед сном, не лежать после еды;
5. избегать тесной одежды и тугих поясов;
6. избегать глубоких наклонов, длительного пребывания в согнутом положении, подъёма тяжестей более 8–10 кг, упражнений с напряжением мышц брюшного пресса;
7. избегать седативных, снотворных средств, транквилизаторов, антагонистов кальция, теофиллина, холинолитиков;
8. прекратить курение.

Жиры снижают давление нижнего пищеводного сфинктера, белки повышают; кофе, чай, шоколад, мята, алкоголь и курение снижают давление сфинктера.

ГЭРБ, как правило, сочетается с гастритом, гастродуоденитом, заболеваниями желчевыводящих путей, поджелудочной железы и кишечника, поэтому базисной диетой являются столы 1, 5, 4. Изголовье поднимают брусками высотой до 15 см под ножки кровати, а не подушками; сон на левом боку уменьшает частоту рефлюкса. Слабоминерализованные щелочные воды принимают в тёплом дегазированном виде за 30–40 минут до еды в течение 4 недель.

4.3 Медикаментозное лечение детей старшего возраста

Детям старше года с пищеводными проявлениями ГЭРБ препаратами выбора являются ингибиторы протонного насоса: омепразол, эзомепразол, #рабепразол — курсом **4–8 недель**, при подтверждённом эзофагите дольше.

1. омепразол — детям **старше 2 лет** 1–4 мг/кг в сутки, максимально 40 мг (в КР одновременно указано «в два приёма» и «1 раз в сутки»);
2. эзомепразол — детям **старше 1 года** 0,5 мг/кг в 1–2 приёма, максимально 40 мг 1–2 раза в сутки;
3. рабепразол — **с 12 лет** до 20 мг в сутки.

При приёме **более 8 недель** учитывают повышение риска метаболических, инфекционных и пищевых расстройств. По эффективности ингибиторы протонного насоса превосходят блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов.

Детям **старше 6 лет** вместе с ингибиторами протонного насоса рекомендуется средство для создания желудочно-пищеводного барьера: натрия гиалуронат и хондроитина сульфат на биоадгезивном носителе полоксамере 407.

Сочетание эффективнее монотерапии ингибиторами протонного насоса в устранении пищеводных и внепищеводных симптомов и эпителизации эрозий.

По 1 пакетику (10 мл) после еды и на ночь; эффективность доказана при применении **4–5 недель**.

При сочетании пищеводных и внепищеводных симптомов внепищеводные симптомы полностью исчезли у 70,5% детей; доля принимавших антациды снизилась с 34,4 до 4,9%.

При невозможности приёма ингибиторов протонного насоса или противопоказаниях селективно применяют #фамотидин 1 мг/кг в сутки курсом **4–8 недель** при эрозивном эзофагите у детей **старше 3 лет**.

Применяется с осторожностью: эффективность ниже, фармакотерапевтический профиль неблагоприятен, высок риск тахифилаксии.

Для быстрого купирования изжоги в комплексной терапии назначают антациды, преимущественно в виде геля или суспензии. Длительно для лечения ГЭРБ не применяются.

1. алюминия фосфат: возраст в КР не указан;
2. алгелдрат + магния гидроксид — **с 10 лет**;
3. натрия алгинат + натрия гидрокарбонат + кальция карбонат — **с 12 лет**.

Синтетические антихолинергические средства и прокинетики применяются селективно: при сопутствующей задержке эвакуации из желудка и (или) запоре; наибольший эффект — при сочетании ГЭРБ с функциональной диспепсией.

Тримебутин

1. дети 3–5 лет: 25 мг 3 раза в сутки;
2. дети 6–12 лет: 50 мг 3 раза в сутки;
3. 12 лет и старше: 100–200 мг 3 раза в сутки.

Итоприд

1. возраст: с 16 лет.

4.4 Противорецидивное лечение

В период стойкой клинико-морфологической ремиссии ингибиторы протонного насоса, блокаторы H2-гистаминовых рецепторов, прокинетики и антациды не рекомендуются.

Для профилактики рецидивов селективно проводятся реабилитационные мероприятия: бальнеолечение, физиотерапия.

ГЭРБ часто протекает на фоне хронического гастродуоденита и колонизации Helicobacter pylori, поэтому в наблюдение включают обследование и ведение по клиническим рекомендациям о патологии желудка и двенадцатиперстной кишки.

Занятия физкультурой рекомендуются в подготовительной группе при неполной клинико-эндоскопической ремиссии и в основной группе при полной.

4.5 Хирургическое лечение

Показания к фундопликации (лапароскопической, по Ниссену)

1. рефрактерность к медикаментозной терапии, то есть отсутствие убедительной клинической и эндоскопической ремиссии за **4–8 недель** стандартной дозы ингибиторов протонного насоса, необходимость постоянной фармакотерапии для контроля симптомов, наличие стриктуры пищевода или пищевода Барретта;
2. жизнеугрожающие осложнения: эпизоды апноэ, рецидивирующая аспирация, реактивные заболевания дыхательных путей, неврологические нарушения, задержка физического развития;
3. тяжёлое основное заболевание (неврологическое, муковисцидоз) при значимом риске осложнений ГЭРБ.

Антирефлюксная хирургия может быть полезна также детям с подтверждённой ГЭРБ, которые не могут придерживаться оптимальной медикаментозной терапии.

Перед операцией исключают причины симптомов, не связанные с ГЭРБ; оперируют только детей с чётко доказанной хронической или рецидивирующей ГЭРБ, взвесив риск и пользу.

Риски фундопликации: вздутие живота, раннее насыщение, дисфагия, позывы на рвоту, демпинг-синдром, аспирация из-за застоя в пищеводе, несостоятельность манжеты с повторной операцией.

Лапароскопическая фундопликация по Ниссену является золотым стандартом и в значительной степени заменила открытую операцию: меньше травматичность и пребывание в стационаре. Робот-ассистированная операция безопасна, но существенных преимуществ не даёт.

Наименьший успех антирефлюксная хирургия даёт при внепищеводных симптомах, включая аспирационную пневмонию, у детей с неврологическими нарушениями.

4.6 Иное лечение

Детям с ГЭРБ и неврологическими нарушениями, проблемами с кормлением, недостаточным набором массы тела селективно проводится кормление через гастростому — для предотвращения осложнений и улучшения нутритивного статуса.

Кормление через гастростому, как правило, проводится без хирургического антирефлюксного лечения, на фоне медикаментозной антирефлюксной терапии по показаниям; при отсутствии эффекта второй линией является хирургическое лечение.

При тяжёлой ГЭРБ и высоком риске аспирации (тяжёлые неврологические нарушения), синдроме короткой кишки с тяжёлой ГЭРБ или дисморикой, когда пероральное и желудочное питание неэффективны, альтернативой фундопликации и гастростоме является кормление через назоеюнальный зонд.

4.7 Медицинская реабилитация

Коррекция образа жизни с обучением позиционированию

1. исключается положение лёжа на спине после еды;
2. сон на левом боку: на правом боку рефлюкс усиливается;
3. после еды допустимо жевание резинки без сахара;
4. исключают кофеин, газированные напитки, шоколад, цитрусовые, томаты, острую и жирную пищу, жирные молочные продукты.

Для улучшения глотания и уменьшения дисфагии селективно назначается лечебная физкультура по методике Р. Шейкер.

Лёжа на спине без подушки поднять голову (смотреть на пальцы ног), не отрывая плеч, удерживать 1 минуту, опустить; повторить ещё 2 раза с отдыхом по 1 минуте. Затем 30 раз поднять и опустить голову.

Для уменьшения дисфагии и изжоги селективно проводится санаторно-курортное лечение: питьевые минеральные воды, терренкуры, климатотерапия.

Возможно применение физиотерапии: синусоидальные модулированные токи, электросон, СВЧ-терапия, структурно-резонансная электромагнитотерапия, низкочастотная магнитотерапия.

Противопоказания к физическим факторам

1. тяжёлая ГЭРБ, осложнённая стриктурами, язвами, кровотечением из вен пищевода;
2. грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, подлежащая операции;
3. пищевод Барретта;
4. доброкачественная или злокачественная опухоль;
5. общие противопоказания к физической терапии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Как правило, лечение в круглосуточном стационаре не требуется, за исключением осложнённого течения и показаний к операции. Для диагностики, коррекции терапии и реабилитации целесообразен дневной стационар.

Показания к неотложной госпитализации

1. повторяющиеся эпизоды апноэ;
2. обильное кровотечение из эрозий или язв пищевода.

Показания к срочной консультации детского хирурга

1. дисфагия;
2. потеря массы тела;
3. гематемезис;
4. рецидивирующая рвота.

Дети с ГЭРБ наблюдаются педиатром или врачом общей практики и гастроэнтерологом, при сопутствующей патологии совместно с соответствующими специалистами.

Осложнённое течение (стриктуры, кровотечения, пищевод Барретта) ведётся совместно с детским хирургом; при подозрении на малигнизацию ребёнка с пищеводом Барретта направляют к детскому онкологу.

5.2 Диспансерное наблюдение

Осмотры педиатра и (или) гастроэнтеролога — **не реже 2 раз в год в течение 3 лет** с момента последнего обращения.

Частота ЭГДС

1. эндоскопически негативная форма и рефлюкс-эзофагит I степени — при обострении;
2. рефлюкс-эзофагит II–III степени — **1 раз в год** и при обострении;
3. рефлюкс-эзофагит IV степени (язва, пищевод Барретта) — **1 раз в 6 месяцев** на первом году, затем **1 раз в год** при клинической ремиссии.

В КР частота ЭГДС задана по степеням рефлюкс-эзофагита I–IV; соответствие Лос-Анджелесским стадиям A–D (вкладка «Клиника») не приведено.

5.3 Профилактика

Меры профилактики в основном совпадают с рекомендациями по изменению образа жизни (вкладка «Лечение»); полный перечень раздела 5.1 КР — в «Подробнее».

Профилактика

1. борьба с лишним весом;
2. ограничение продуктов, повышающих внутрибрюшное давление (газированные напитки, бобовые) и усиливающих рефлюкс (кофе, шоколад, жирная и острая пища);
3. ограничение продуктов с кислотостимулирующим действием (мучные изделия, цитрусовые, специи, жареное, редька, редис);
4. еда небольшими порциями, медленно, без разговоров;
5. подъём тяжестей не более 8–10 кг;
6. изголовье кровати приподнято на 10–15 см;
7. ограничение лекарств, расслабляющих пищеводный сфинктер;
8. не принимать горизонтальное положение **2–3 часа** после еды;
9. разъяснение вреда табачного дыма и алкоголя.

ГЭРБ не является противопоказанием к вакцинации вакцинами любого типа.

5.4 Осложнения и прогноз

Грозные осложнения ГЭРБ — пептическая стриктура пищевода при рубцевании язв, пищевод Барретта (предраковое состояние; у детей с эзофагитом 6,2–13%) и постгеморрагическая анемия при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы или эрозивно-язвенном поражении.

У большинства детей прогноз благоприятный. При пищеводе Барретта сохраняется вероятность аденокарциномы или плоскоклеточного рака; неблагоприятные признаки — метаплазия на протяжении 8 см и более и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 30.09.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2028 года
Код в рубрикаторе	`402_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Российская ассоциация детских хирургов; Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов; Национальная ассоциация детских реабилитологов; Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Доза омепразола: в одной фразе указано «до 40 мг в два приема» и «1 раз в сутки» (раздел 3.1.2).
- Обобщённый показатель DeMeester «в норме не должен превышать значений» — пороговое число в тексте пропущено (раздел 2.4).
- Частота ЭГДС при диспансерном наблюдении задана по степеням рефлюкс-эзофагита I–IV, а классификацией в разделе 1.5 служит Лос-Анджелесская (стадии A–D); соответствие степеней и стадий не приведено (раздел 5.2).
- Объём срыгиваний при лёгком течении («объемом 2,5-5,0») приведён без единицы измерения (раздел 1.6).